



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : اسماء السيد عطيه عبدالله
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الصف
العنوان : +++++
رقم البطاقة : 27809161500408 رقم التليفون : 01149086653
العمر (تاريخ الميلاد) : 16-09-1978 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- / د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: اسماء السيد عطيه عبدالله National ID: 27809161500408	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

اسماء
انسيد عطيه عبدالله
ش الاهرام
مركز الصف - الجيزة

١٩٧٨/٠٩/١٣
٢٧٨٠٩١٦١٥٠٠٤٠٨
LI6983146



٢٠٢٥/٠٩/٢٧ ٢٧٨٠٩١٦١٥٠٠٤٠٨

حاصله على دبلومة زراعي

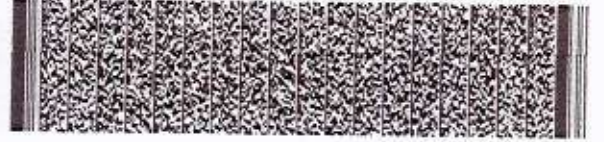
أنثى مستلمة متزوجة

على فوزى السيد ابوالخير

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٩/٠٥



١



Name: <u>اسماء السيد عطيه</u>		
MR. : <u>266</u>		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحية طيبة وبعد,,		
إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:	رقم طبي:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
تاريخ وساعة الدخول :	تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها was CT3 N1 , triple positive , 21/3/2022-->LT MRM POST NACT NO RESIDUAL VIABLE,,IDC GII...LN 0/16 FREE RESECTION MARGIN...CPR STAGE YPTO YPNO (MDT OUTCOME to complete 1 year of HP ,PORT , tamoxifen) patient recieved tamoxifen for 28 months , shifted to arimidex to recieve zoladex + arimidex today Referred from the oncology clinic >> Skin benign looking polyp at the Rt inner thigh appeared 2 m ago gradually increasing in size >> for MDT sm 8/2025 left operative bed mass birads 4 b biopsy fat necrosis no maluignancy on exam nad for zoladex zometa arimidex		
تحريراً في ,		
التاريخ :	الوقت :	19-09-2026
الطبيب المعالج :		علياء احمد أبو النصر شهاب الدين
يعتمد ,		



٢٠٢٥/٠٩ ٢٧٨٠٩١٦١٥٠٠٤٠٨
حاصله على دبلوم زراعي

متزوجة
أنثى
مسلمة
على فوزى السيد ابوالخير
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٩/٠٥

DMS
سواركن البن والصورى
تعليل وضوضها ت



اسماء
السيد عطيه عبدالله
٢٧٨٠٩١٦١٥٠٠٤٠٨
مركز الصف - الجيزة

٢٧٨٠٩١٦١٥٠٠٤٠٨
LI6983146



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

البنية التحتية
صحة
مصر

02/25/2026

MDT FORM

Name:	Asmaa Sayed Atiah .	MRN:	266
Age:	47 Y	ID:	CVN-91710--2-1
Menopausal Sta		Phone:	01149086653
NRS SCORE:		Marital Status:	MARRIED
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	MF , Hx of it MRM post NACTH now on hormonal ttt	Reason Of MDT:	new non breast lesion presentation

Clinical Data:

BX:		R		L			
ER:		PR:		HER2:		KI67:	

Sonomammography:Mets Workup:History:

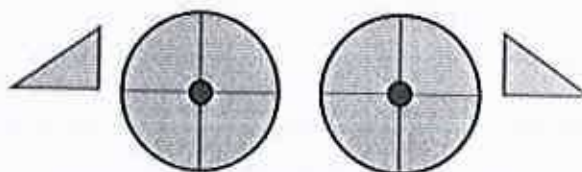
Skin benign looking polyp at the Rt inner thigh appeared 2 m ago gradually increasing in size

Recommendations:

for possibility of ex bx

MDT Outcome & Plan

for excision



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ نيل حسن	د/ عبد السلام شادي	د/ نزيهين ومضان			



Patient Name	: الأستاذ / أسماء السيد عطيه	Request No.	: 13009384
Patient No.	: 27809161500408	Request Date	: 13/03/2023
Path No.	: 769/23	Verification Date	: 21/03/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.
Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

- * Procedure: Left MRM measured 25x17x6.5 cm with covering skin ellipse measured 20x16 cm. Axilla measured 5x4x2cm.
- * Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.
- * Size: 9x6 cm.
- * Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- * Distance from margins: 1.5cm away from deep margin.
- * Lymph nodes number and size: 16 L.Ns up to 1cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: No residual viable tumour tissue in previously diagnosed Invasive duct carcinoma GII.
- * Ductal carcinoma in situ: No.
- * Skin involvement: Free nipple and areola.
- * Lymph node involvement: Negative 0/16.
- * Resection Margins: Free.
- * Histologic response to therapy: Complete pathological response.

Diagnosis:

Left breast cancer post NACT, MRM specimen:

- * No residual viable tumour tissue in previously diagnosed Invasive duct carcinoma GII.
- * Free nipple and areola.
- * Lymph node were Negative 0/16.
- * Free resection Margins.
- * Complete pathological response to therapy.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 08/04/2023 09:21:25

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذة / اسماء السيد عطيه	Request No.	: 13009384
Patient No.	: 27809161500408	Request Date	: 13/03/2023
Path No.	: 769/23	Verification Date	: 21/03/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Stage: ypT0 , ypN0.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Heba Hassan.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 08/04/2023 09:21:25

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

خريطة رقم (4) - الدور الثاني - مبنى رقم (987) - المبنى الثاني - معمل الباثولوجي - دار السلام - مصر
Room No. (4) - First Floor, Building No. 987 - Nile Corniche - Mite El Qadima Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / أسماء السيد عطيه

Patient No. : 27809161500408

Path No. : 2670/22

Sex : Female

Age : 44 Y

Referring Doc. :

Request No. : 13001987

Request Date : 10/09/2022

Verification Date : 26/09/2022

Financial Category : اورام دار السلام - مبادره

Department : Out Patient

IHC No. :

Registered by : .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT**Clinical Data:**

Left breast mass.

Nature of the specimen:

Tru cut biosy collected at 10/9/2022 at 11.10am.

Gross Examination:

- Three grayish white tissue cores up to 1.5cm, totally submitted.
- Immunohistochemical technique: Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (SP1), PR clone (1E2), HER-2 CLONE (4B5), & Ki67 (30-9).

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1).
- Lympho-vascular invasion: No in the received material.
- Ductal carcinoma in situ: positive.
- IPT:

Examination of ER stained slide show intense nuclear staining in 80% of the tumor cells. ✓

Examination of PR stained slide show intense nuclear staining in 40% of the tumor cells. ✓

Examination of HER2 stained slide show intense complete membranous staining in >10% of tumor cells.

Examination of Ki67 stained slide show nuclear staining in 15% of tumor cells. ✓

Positive tissue control showed appropriate reactivity

Diagnosis:

Left breast mass; Tru cut biosy:

Verified by :

Printing Date : 26/09/2022 14:52:44

Page 1 of 2

Printed By : hermal

Request No.	13001987
Request Date	10/09/2022
Verification Date	26/09/2022
Financial Category	اورام دار السلام - مبادرہ
Department	Out Patient

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- Invasive duct carcinoma GII with Duct carcinoma insitu component.
- IPT :
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 6/8).
- HER-2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 15% of tumor cells.

Prof. Amal Hareedy.
Dr.Menna Nabil.

Verified by :

Printing Date : 26/09/2022 14:52:44

Page 2 of 2

Printed By : hermal

Patient Name: Asmaa Al Sayed Ateya Abd Allah	Date : 07/12/2024
Exam: C.T CHEST	Age: 46 Year(s)
Medical ID: 3815/2022	Pat. ID: 18643

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST:-

**Comparing to last study done at 9/3/2023, The current study showing:*

Findings:

- * Evidence of left breast MRM with reconstruction and left axillary intervention showing operative bed thickened sheets studded with scattered irregular isodense lesions largest measures 2.5x1.5cm seen at lateral aspect of the scar, some of them showing central fat density likely post-operative changes
- * Right breast is partially out of field
- * No pulmonary parenchymal masses, consolidation or cavitary lesions.
- * Few subcentimetric mediastinal lymph nodes
- * No evidence of pleural effusion.
- * Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- * Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- * Stable DS ,8 and 9 tiny faint sclerotic lesions.
- * Upper abdominal cuts are unremarkable.
- * Still noted right sided porta-cath

OPINION:

- * *Evidence of left MRM with reconstruction and operative bed post-operative changes*
- * *No CT evidence of chest infection or pulmonary metastatic lesions.*

Dr. Walid Mohamed, M.D.

التاريخ: 11.10.2022

الاسم: اسماء السيد عطيه

Tc-99m MDP DUAL PHASE BONE SCAN:**History**

- 44-year-old lady presented with history of left breast cancer and referred for metastatic workup.

Procedure:

- Early blood pool and late osseous whole body scans were obtained at 5 minutes and 2 hours post tracer injection, respectively.

Findings:

- The scanned skeleton is free from abnormal active or cold foci that would account for serious or malignant/metastatic bone lesions.
- Degenerative changes of the spine are noted.
- The early blood pool scans are unremarkable.

Opinion:

- No metastatic skeletal lesions detected on scintigraphic basis.

Much obliged,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

Call Center **19656**

Patient Name: Asmaa Al Sayed Atteya Abd Allah	Date : 08/09/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 1897	

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication: Left breast mass

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

LEFT BREAST:

- Regional left breast asymmetry harboring malignant spiculated dense mass lesions and malignant pleomorphic calcifications measuring collectively about 1.7x10 cm.
- Increase of areolar skin thickness
- Complementary U/S revealed multiple ill defined malignant looking hypoechoic solid mass lesions with infiltrated intervening parenchyma extending from 11 to 4 o'clock surrounding by area of altered parenchyma and showing anterior ductal extensions reaching to the nipple, the largest mass lesion located at 2-3 o'clock measuring about 5x3.5 cm. Color Doppler showed abnormal internal vascularity.
- Multiple pathological axillary (level I and II) lymph nodes with effaced fatty hila and uniform increase of cortical thickness.
- Indeterminate supraclavicular lymph nodes

RIGHT BREAST:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- benign macrocalcifications
- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Retroareolar dilated ducts.No cystic or solid mass lesions by U/S.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex.
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Left breast locally advanced multicentric malignant process with pathological axillary lymph nodes for histopathological correlation(BIRADS 5)
- Right breast benign findings (BIRADS 2)

Yours truly

Dr/Asmaa Zeinhom, MSC.



جهاز الإصدار: فرع الجيزة

تاريخ الإصدار: 2023-7-4

إلى من يهمه الأمر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 "الأطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقاً لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقاً لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) اسماء السيد عطيه عبد الله بطاقة رقم 27809161500408
وطبقاً إلى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون أي مسؤولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكراً

تاريخ الطباعة: 2023-7-4



إفادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،



مستمل 834121



الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار